Facies, ojos, párpados y cejas

SEMIOLOGIA · Clase 07 · la cara como tarjeta de presentación de la enfermedad

1 · QUÉ ES UNA FACIES Y CÓMO SE MIRA

Facies
rasgos del rostro que recuerdan una enfermedad; se leen antes de palpar, percutir o auscultar

para leerla se hace la

si no hay patrón se informa

Facies atípica o normal
no se reconoce ningún patrón característico

Cómo se mira
de lejos y con buena luz: primero el color, luego la forma, después los ojos y la expresión

primero mira el color

después mira la forma

otras expresiones

2 · EL COLOR: CORAZÓN, ALTURA Y SHOCK

Por qué cambia el color
el bajo gasto, la hipoxemia crónica o el colapso circulatorio alteran la sangre que llega a la piel

con bajo gasto y estasis

con pulso de gran amplitud

con hipoxemia crónica

con colapso circulatorio

Mitral F2 · F3
cianosis en pómulos, nariz, labios y mentón, con el resto de la cara pálido (bajo gasto y estasis pulmonar)

por eso orienta a

Estenosis mitral F3

Aórtica F3
palidez peribucal, signo de Musset y latido visible de temporales y carótidas

por eso orienta a

Insuficiencia aórtica F3

De Ayerza F10
cara entera oscura por cianosis intensa y poliglobulia: los «cardíacos negros»

en Puno se explica por la

Altura de Puno, 3820 msnm F10
Hb de 24-26 g/dL frente a 16 en la costa

con los años lleva al

Cor pulmonale crónico F10
la sangre espesa sobrecarga el corazón derecho

Hipocrática F1
ojos hundidos, nariz afilada, labios finos, sudor y palidez, cianosis labial

anuncia un

Shock inminente F1

es típico de

Peritonitis, shock profundo o deshidratación F1

si es bilateral recuerda la

en los párpados busca

3 · LA FORMA: HORMONAS Y LEPRA

Forma y volumen
la grasa se redistribuye, los tejidos se infiltran o se afilan por pérdida de líquidos

si el cortisol sobra

si falta hormona tiroidea

si el bacilo infiltra la piel

Cushing o luna llena F4
cara redonda, roja y tensa, acné e hipertricosis en la mujer

no confundir: también es redonda

Mixedematosa
redonda pero pálida y apática, nariz y labios gruesos, párpados edematosos, cejas ralas

orienta a

Hipotiroidismo avanzado

Leonina F8
piel engrosada con lepromas confluentes en frente y mejillas, nariz ancha y espesa

por la micobacteria indica

Lepra lepromatosa F8
por Mycobacterium leprae

por el exceso de cortisol

Exceso de cortisol F4
redistribuye la grasa a cara y cuello

sea suprarrenal o por fármaco

Hiperfunción suprarrenal o corticoides prolongados F4

el patrón se ordena por

4 · LA EXPRESIÓN: MÚSCULO Y NERVIO

Otras expresiones
parkinsoniana (rigidez que quita la mímica) y miasténica (caen párpados y mandíbula)

al final mira la expresión

Sardónica F9
mueca fija, falsa sonrisa, por contractura sostenida de los músculos de la cara

con apertura limitada hay

Trismus F9
contractura del masetero: no se abre la boca

es típico del

Tétanos F9
por la toxina tetánica

5 · LOS OJOS: GLOBO, PUPILA Y HORNER

luego mira los ojos

Mirar el ojo
posición del globo, pupila, párpados, córnea y cejas

si el globo protruye con bocio

si el globo se hunde

se compara el tamaño de la

Basedowiana F5
exoftalmos, mirada brillante, rostro delgado y bocio

con retracción palpebral hay

orienta a

Signo de Stellwag F5
parpadeo escaso por la retracción palpebral (literatura)

Hipertiroidismo de Basedow-Graves

Enoftalmos
globo hundido: bilateral en la deshidratación, unilateral orienta al Horner

si es unilateral piensa en

Claude Bernard-Horner F13
miosis, ptosis y enoftalmos de un solo lado

con la pupila chica es

se debe a la

Parálisis del simpático cervical F13
el que normalmente dilata la pupila y levanta el párpado

clásicamente por un

Tumor del vértice pulmonar F13
o aneurisma de aorta, lesión de hipotálamo o protuberancia

Pupila normal
2 a 4 mm, redonda, central e igual en ambos ojos

fuera de ese rango hay

Miosis y midriasis
miosis menos de 2 mm; midriasis más de 4 a 7 mm según el autor

6 · PÁRPADOS, CÓRNEA Y CEJAS

Edema palpebral
hinchazón del párpado

si afecta ambos lados

hincha ambos párpados

si afecta un solo lado

Bilateral: causa sistémica F7
nefrótico, nefrítico o mixedema

Unilateral: causa local F7
edema de Quincke, infección o signo de Romaña (Chagas)

en el ángulo interno ve

Xantelasma F12
placas amarillas sobreelevadas en el ángulo interno del párpado

en el borde corneal ve

Arco senil F11
anillo blanco grisáceo en la periferia de la córnea

en las cejas ve

se forma por

Depósito de lípidos F11 · F12
sugiere hipercolesterolemia; el arco también aparece en la edad avanzada

por eso sugiere

con cejas ralas, produce

Madarosis F6
caída de las cejas, sobre todo del tercio externo

clásicamente orienta a

Hipotiroidismo F6
la clásica; también lepra, desnutrición avanzada, sífilis y esclerodermia

lo opuesto, cejas unidas:

Sinofridia F14
cejas pobladas unidas en la línea media

se interpreta como

Variante normal o rasgo asociado F14
el banco responde acromegalia (relación dudosa); la literatura cita hirsutismo

7 · QUÉ ORIENTA: AGRUPAR POR ORIGEN

Agrupar por origen
cardiovascular, endocrino, infeccioso, renal, neurológico u oncológico

por eso

Orienta qué aparato examinar primero
y qué análisis pedir: hemoglobina, tiroides, cortisol o lípidos

concepto · desenlace · técnica · mecanismo · signo · complicación · ejemplo · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor 2020 y 2018 · 05k Facies y 06a Cabeza, cara y ojos — teoría del docente (= literatura)